Guide du module Isolement et contention

Tessera Santé, module Isolement et contention (Isocont) — à lire en 10 minutes. La connexion, l'onglet Patients, le mode formation, le journal et les éléments communs de l'administration sont décrits dans le guide utilisateur (document 06). Ouvrez le module par la barre des modules, en bas de l'écran ; son onglet Patients *montre les statistiques d'isolement et de contention par patient (la liste des patients elle-même a sa fenêtre* Patients*). Pour les IDE et aides-soignant(e)s, un guide pratique illustré reprend les gestes du quotidien : document 08 du kit.*

Ce guide parle de « chambre de soins intensifs (CSI) ». Si votre établissement emploie une autre appellation (chambre d'isolement, espace d'isolement…), l'outil affiche la sienne.

Les couleurs des échéances

Couleur	Signification
Vert	Dans les temps
Jaune	Échéance dans moins de 12 h
Rouge	Échéance dépassée
Bleu	Fait à temps
Violet	Fait hors délai
Gris	Sans objet (mesure terminée avant l'échéance)

IDE et aides-soignants (AS)

IDE et AS disposent des mêmes droits.

Nouvelle mesure (onglet *Mesures → + Nouvelle mesure*) : vous reportez la décision du psychiatre. - Choisir le patient (ou *+ Nouveau patient* avec son identifiant permanent du patient, IPP : si l'IPP existe déjà, l'outil propose sa fiche). La **date de naissance est obligatoire** pour un nouveau patient, et demandée si elle manque dans une fiche existante. - Lisez les **alertes en rouge** qui apparaissent sous les champs pendant la saisie : patient mineur, patient en soins libres, mode « SL mineur » incohérent avec l'âge, mesure du même type déjà en cours (doublon possible), cumul élevé sur 15 jours, mesure de protection juridique, saisie tardive, contention hors espace d'isolement. Elles n'empêchent pas l'enregistrement (sauf date dans le futur) : elles signalent ce qu'il faut vérifier ou régulariser. - Vérifier le mode d'hospitalisation. - Type, date et heure **de la décision**, psychiatre, lieu. - Pour une contention en chambre de soins intensifs sans isolement en cours, l'outil propose de créer aussi l'isolement : laissez la case cochée.

Fin de mesure : bouton *Fin* sur la ligne, avec la date, l'heure et le psychiatre qui a décidé l'arrêt. Une mainlevée du juge ne termine pas la mesure : c'est toujours la décision médicale qui y met fin.

Pause (levée temporaire) : quand le psychiatre lève temporairement la mesure (repas, douche, visite…), bouton *Pause* sur la ligne. Indiquez le début, puis **une durée** (raccourcis 30 min, 1 h, 2 h, 4 h) **ou une heure de reprise**, le motif et le psychiatre. Pour un isolement avec une contention en cours, la contention est mise en pause en même temps (case cochée par défaut : une contention ne peut pas se poursuivre hors isolement ; si vous la décochez, une alerte le rappelle et le tableau de bord le

signale). Si l'établissement a activé le verrou, choisissez entre mettre aussi la contention en pause ou y mettre fin au début de la pause. Pour une **contention pendant un isolement**, indiquez obligatoirement si la pause concerne la contention seulement (le patient reste à l'isolement) ou aussi l'isolement (le patient sort de l'isolement) ; à la reprise, l'outil propose de reprendre les deux. - La pause **ne met pas fin à la mesure**. Selon le choix de l'établissement, sa durée est soit comptée (la durée et les échéances du juge des libertés et de la détention (JLD) continuent de courir, réglage par défaut), soit déduite du cumul (les échéances JLD sont alors reportées d'autant). La fenêtre de pause indique le réglage en vigueur. La ligne apparaît hachurée avec un badge *Pause → heure de reprise*. - Au retour du patient, bouton *Reprise* : l'heure prévue est proposée, corrigez-la si besoin. Si l'heure prévue est dépassée sans reprise saisie, le badge passe au rouge et le tableau de bord le signale. Si l'établissement a activé la **reprise automatique**, la mesure reprend d'elle-même à l'heure prévue : ne saisissez une reprise que si elle a lieu plus tôt. - Si le psychiatre décide de ne pas reprendre, utilisez *Fin* : la date proposée est le début de la pause. - Au-delà d'une durée réglée par l'administrateur (12 h par défaut), une alerte demande de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une fin de mesure ; au-delà d'un second seuil (48 h par défaut, et jamais plus), la pause est refusée : c'est une fin de mesure.

Changement de lieu (d'une chambre de soins intensifs, CSI, vers une chambre, par exemple) : *Détail → Changer de lieu…*. Pour une simple erreur de saisie, demandez une correction à votre cadre.

Information du tiers : bouton *Tiers*. Indiquez le résultat (informé, tentative sans succès, pas de tiers, refus du patient…), la qualité du tiers et qui l'a informé : le psychiatre (choisi dans la liste) ou une autre fonction prévue par l'établissement (IDE, cadre de santé…), avec le nom de la personne si besoin. À renouveler à chaque nouveau cycle JLD. La liste des fonctions se règle dans *Administration → Établissement et services* ; le psychiatre y figure toujours en premier, l'article L. 3222-5-1 confiant cette information au médecin. L'extrait de l'article (II) est consultable dans la fenêtre *Tiers* et dans le réglage, avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1127 QPC du 5 mars 2025 : pour un majeur protégé, informer aussi la personne chargée de la mesure de protection (un rappel s'affiche quand la fiche du patient indique une protection juridique).

Surveillance en CSI : onglet *Surveillance CSI*. Chaque poste attend le nombre minimal de professionnels fixé par l'établissement (deux par défaut, *Administration → Établissement et services*) ; complétez les noms et fonctions des professionnels présents. *M'ajouter* vous enregistre en un clic pour le poste (tous les lieux du service). La fenêtre *Ajouter* présente la **liste des agents de l'équipe** à cocher (comptes affectés au service portant les rôles choisis par l'établissement, IDE et AS par défaut ; réglage dans *Administration → Établissement et services → Postes de surveillance*), avec une recherche au-delà de huit agents ; les agents déjà inscrits sont grisés. Une **autre personne**, sans compte (intérim, renfort, étudiant), s'ajoute par son nom et sa fonction ; les noms saisis dans le service au cours des trois derniers mois sont proposés. Un professionnel est compté pour tous les lieux du service, sauf s'il précise les lieux surveillés : il n'apparaît alors au registre que pour les mesures de ces lieux. Ces informations alimentent le registre.

Exports (bouton *Exports* en haut de l'écran) : décomptes JLD (PDF, CSV), registres, statistiques, registres pour communication, données d'un patient et archives sont **enregistrés automatiquement dans le dossier des exports** (sous-dossier du dossier des données, « exports » par défaut, réglable dans *Administration → Sauvegardes et exports*), rangés **par service** (`exports\<service>\<catégorie>`, et `exports\Etablissement` pour ce qui couvre plusieurs services) et tracés au journal. Chaque agent ne voit que les fichiers de ses services. Si l'administrateur a renseigné le **chemin réseau** du dossier des données, la fenêtre affiche le chemin Windows du dossier du service, avec *Copier le chemin* (à coller dans l'Explorateur) et la marche à suivre pour *Créer un raccourci sur le bureau* (clic droit sur le bureau → *Nouveau* → *Raccourci*, coller le chemin ; un navigateur ne peut pas ouvrir lui-même l'Explorateur, et Edge comme Chrome bloquent le téléchargement d'un fichier de raccourci). La fenêtre liste les fichiers : *Ouvrir* (PDF), *Télécharger* (copie sur le poste), *Supprimer*

(administrateur, tracé). Ces fichiers ne sont pas chiffrés : ils restent sur le réseau de l'établissement. **Durée de conservation** réglable par l'administrateur (même écran : aucune purge par défaut, ou de 1 mois à 5 ans) : à la première connexion de la journée sur chaque poste, les exports plus anciens sont supprimés et la purge est inscrite au journal ; l'écran indique combien de fichiers sont concernés avant d'enregistrer, et *Purger maintenant* l'applique tout de suite. Si le dossier est inaccessible, le fichier est téléchargé sur le poste avec un avertissement. Les copies de sauvegarde et les mots de passe provisoires restent téléchargés à part.

Envois JLD le week-end ou en l'absence du secrétariat : voir ci-dessous.

Secrétariat

Onglet *JLD* : les mesures en cours, triées par urgence. - *Saisir un envoi ou une décision* : information du JLD, saisine, ou décision reçue (maintien ou mainlevée), avec la date et l'heure réelles. - Une décision de **maintien** ouvre automatiquement le cycle suivant ; pensez au tiers, qui doit être informé de ce renouvellement. - Colonne *Tiers* : tant que l'information d'un proche n'est pas enregistrée pour le cycle, la mention « Proche à informer avant le ..., comme le juge » reprend l'échéance de l'information du juge ; la règle s'affiche au survol. - *Décompte* (onglet *Mesures*) : document à joindre à la communication, mis en forme selon le masque du service. Le N° désigne la mesure (1 = première mesure prise en compte dans les 15 jours) ; une mesure présentée sur plusieurs lignes porte des numéros de tranche (2.1, 2.2...) et son statut (en cours ou terminée) figure sur chacune de ses lignes. Le **lieu exact** figure avec le type d'espace, dans l'identité et dans la colonne *Lieu* de chaque ligne (« CSI 1 — chambre de soins intensifs », « Chambre 12 — hors chambre de soins intensifs ») ; un changement de lieu en cours de mesure (transfert, soins somatiques) ouvre une nouvelle ligne. Un lieu enregistré sans nom précis (« CSI » seul, mesures importées sans nom de lieu) apparaît comme « nom du lieu non précisé » : nommez les chambres une à une dans *Administration → Établissement et services* (« CSI 1 », « CSI 2 »...). Les levées temporaires y figurent dans un tableau (début, reprise, durée, motif, psychiatre, prise en compte) précédé d'une phrase qui explique la règle de l'établissement ; si les pauses sont déduites, chacune interrompt le tableau du décompte par une ligne grisée « PAUSE » dont la durée est marquée « (déduite) » et n'est pas ajoutée au cumul, et la ligne suivante reprend à l'heure de reprise. Le décompte emploie toujours « déduite du cumul » ou « comptée dans le cumul », jamais « décomptée », qui prête à confusion. *Enregistrer en PDF* crée directement le fichier PDF dans le dossier des exports (masque, papier à en-tête, mise en évidence et numéros de page compris), sans passer par l'impression ; *Imprimer* l'envoie à l'imprimante. *Exporter (CSV)* n'apparaît que si l'établissement l'a activé dans le masque (désactivé par défaut) : mêmes données, pour un tableur. Ces fichiers sont nominatifs : enregistrez-les uniquement sur le réseau de l'établissement.

Cadre de santé

- **Tableau de bord** : échéances, tiers à renseigner, postes de surveillance incomplets, points de vigilance (patient en soins libres, mineur, cumul élevé), saisies en conflit.
- **Patients** : cumuls sur 48 h et 15 jours, niveau de vigilance, mode d'hospitalisation et son historique. Pour l'année choisie, colonnes du registre par patient (par défaut : isolement seul A–B, contention seule D–E — en rouge si elle n'est pas à 0 —, isolement + contention C), avec nombre d'entrées et durée cumulée, et colonne *Mesures (JLD)* qui compte isolements et contentions séparément, comme le juge. Les colonnes se paramètrent dans *Administration → Registre et statistiques → Onglet Patients : statistiques annuelles*. Le bouton *Mesures* de la ligne ouvre la liste détaillée des mesures du patient (accès au détail et au décompte de chacune) et ses entrées du registre.

- **Corrections** : *Détail → Corriger…* (motif obligatoire) ; *Annuler* une saisie erronée dans le détail. Tout reste visible dans le journal.
- **Rôles et accès** (*Administration → Comptes et sécurité*) : chaque rôle ouvre des accès cochés en langage courant (fiches patient, début et fin des mesures, pauses, tiers, envois au JLD, surveillance, corrections, annulations, statistiques, registre pour communication…). Les rôles fournis (IDE, AS, secrétaire, cadre de santé) se renomment et se règlent (*Rétablir les droits par défaut* pour revenir en arrière) ; *Nouveau rôle* en crée un, vide ou copié d'un autre (ex. « Direction des soins », « Consultation »). Un rôle peut donner accès à tous les services, sans affectation au compte. Un compte cumule les accès de ses rôles ; un rôle sans accès permet seulement de consulter. Le rôle Administrateur est fixe. Les changements sont confirmés, tracés au journal et annulables.
- **Onglets affichés selon le rôle** (même écran, rubrique *Onglets affichés* de chaque rôle) : chaque onglet peut être masqué pour un rôle (*Tableau de bord*, *Mesures*, *Patients*, *JLD*, *Surveillance CSI*, *Registre*, *Statistiques*). Le *Journal* se règle par *Journal des saisies* ; *Administration* reste réservé à l'administrateur. Si le tableau de bord est masqué, l'agent arrive sur le premier onglet affiché. Si *JLD* ou *Surveillance CSI* est masqué, le tableau de bord n'affiche plus non plus les échéances JLD ou les postes de surveillance à compléter. Un rôle doit garder au moins un onglet. Un agent qui cumule des rôles voit un onglet dès qu'un de ses rôles l'affiche ; l'administrateur voit toujours tous les onglets. Par défaut, rien n'est masqué.
- **Rôle « registre seulement »** (même écran, *Nouveau rôle* à partir du modèle *registre seulement*, ou case *Accès limité au registre* d'un rôle créé) : les agents qui le portent ne voient que l'onglet *Registre*, tel qu'il s'affiche habituellement. Les patients y sont désignés par leur identifiant (IPP) et leur âge, avec le psychiatre et les soignants chargés de la surveillance. Ces agents n'ont accès ni aux mesures, ni aux fiches patient, ni au journal, ni à la fenêtre des exports, et ne peuvent rien saisir. Ils peuvent imprimer le registre et l'enregistrer en PDF ou en CSV. Ce rôle convient par exemple à un membre d'une instance, à la direction ou à un chargé de qualité. Cumulé avec un rôle plus large, c'est le plus large qui s'applique.
- **Voir l'affichage d'un rôle** (administrateur) : la liste *Affichage* de l'en-tête montre l'outil tel qu'un agent portant ce rôle le voit : onglets, boutons, journal. L'aperçu porte sur tous les services ; le choix d'un service dans la liste des services montre ce que voit un agent de ce service. Pendant l'aperçu, un bandeau orange le rappelle et **aucune saisie n'est enregistrée**. *Revenir à mon affichage*, ou le verrouillage, met fin à l'aperçu. Utile pour vérifier un réglage des rôles et accès.
- **Journal des saisies selon le rôle** (même écran, réglage *Journal des saisies* de chaque rôle) : journal complet ; saisies de ses services (les saisies sur les patients et les mesures de ses services, et ses propres saisies, sans les opérations sur les comptes, le paramétrage, les imports et les exports) ; ses propres saisies seulement ; ou pas d'accès (onglet *Journal* masqué). Par défaut, IDE, AS et secrétaire voient les saisies de leurs services, le cadre de santé et l'administrateur le journal complet. Un agent qui cumule des rôles a le niveau le plus large. Les saisies en conflit s'arbitrent dans le journal : un rôle qui peut annuler doit voir au moins les saisies de ses services.

Annuler depuis le journal (onglet *Journal*, bouton *Annuler* sur la ligne) : le cadre annule les saisies sur les mesures et les patients ; l'administrateur annule aussi les réglages (le réglage reprend sa valeur précédente), les imports et les prises d'acte d'intégrité. Une fenêtre décrit l'effet et demande un motif. Rien n'est effacé ; une annulation faite par erreur se défait avec *Rétablir* sur la ligne de l'annulation. Les traces de comptes (création, mot de passe…) ne s'annulent pas. - **Conflits** : *Journal → Saisies en conflit à arbitrer* (chaque agent y voit les conflits des saisies qu'il peut voir dans le journal). - **Registre** : par service et par année, imprimable, exportable en CSV et **enregistrable en PDF** (papier à en-tête, marges, en-tête, pied de page et bloc signature du masque du décompte JLD du service ; mention «

document confidentiel ») ; il désigne le patient par son IPP et son âge (art. L. 3222-5-1) et n'est présenté qu'à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), au Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et aux parlementaires. - **Version pour communication (CADA)** (onglet *Registre*, cadre et administrateur ; demande d'un tiers au titre de l'accès aux documents administratifs, sous le contrôle de la Commission d'accès aux documents administratifs, CADA) : pour toute autre demande, choisissez les occultations (identifiant patient, âge, dates, psychiatre, soignants, lieu, mode d'hospitalisation, levées temporaires) ; les choix recommandés sont présélectionnés et un avertissement accompagne les choix moins protecteurs. Indiquez la référence de la demande : l'impression ou l'export est tracé dans le journal. Selon le paramétrage, la durée est réelle ou hors pauses (indiqué sous le tableau), avec une colonne des levées temporaires si elle est activée. - **Statistiques** : rapport annuel comparé à l'année précédente, enregistrable en PDF avec le papier à en-tête (masque du service, ou de l'établissement pour plusieurs services). Saisissez le nombre de patients en hospitalisation complète et sous contrainte (chiffres du département d'information médicale, DIM) pour obtenir les pourcentages.

Administrateur

Les rubriques communes à toute la plateforme (sauvegardes, dossier de secours, travail hors réseau, exports, réglages, choix du dossier bloqué) sont rappelées ici telles qu'elles s'appliquent au module ; elles valent pour tous les modules.

Nouvelle version (outil ouvert depuis sa page GitHub seulement) : un bandeau en bas de l'écran annonce une version plus récente ; enregistrez la saisie en cours, puis *Recharger la page* (ou *Plus tard*). Si le bandeau indique que la version n'est pas encore entièrement disponible, réessayez quelques minutes plus tard. L'administrateur peut désactiver cette vérification (*Administration → À propos → Mise à jour de l'outil*), qui propose aussi *Vérifier maintenant*.

Sauvegardes et exports (*Administration → Sauvegardes et exports*) : un seul sous-onglet réunit l'état des données et les sauvegardes (copie sous scellé, copie complète, contrôle d'intégrité, restauration), le dossier de secours et le travail hors réseau, le dossier des exports (emplacement, chemin réseau, durée de conservation, bouton *Voir les fichiers exportés*), l'archive annuelle et l'export ou l'import des réglages. Le détail de chaque rubrique suit.

Copie automatique par robocopy (*Administration → Sauvegardes et exports*) : *Installer une copie automatique par robocopy…* (dossier de secours) et *Tenir la copie locale à jour par robocopy…* (poste désigné) préparent, avec les chemins exacts, les commandes à coller une fois dans PowerShell ouvert en administrateur sur la machine concernée. Pour une copie locale, le choix *Ma session Windows seulement* ne demande aucun droit d'administrateur (copie faite pendant cette session seulement). Ces commandes enregistrent le script, font une première copie et créent la tâche planifiée (documents 09 et 10).

Dossier de secours et déplacement (*Administration → Sauvegardes et exports*) : choisir un second dossier, de préférence sur un autre serveur, et y relier ce poste ; il reçoit une copie des données chiffrées (sans les exports) à la connexion puis toutes les 10 minutes, depuis chaque poste relié (reliez au moins un poste utilisé chaque jour ; un point de vigilance apparaît après 24 h sans synchronisation). Si le dossier principal est inaccessible, ouvrez le dossier de secours (*Changer de dossier*, bandeau rouge) ; au retour, ouvrez le dossier principal et *Synchroniser maintenant* : les saisies faites entre-temps sont reprises. *Déplacer les données vers un nouveau dossier* copie et vérifie toutes les données dans un dossier vide ; l'ancien dossier ne s'ouvre plus ensuite (chaque poste choisit le nouveau). Voir aussi les procédures de secours (document 04).

Travail hors réseau (*Administration → Sauvegardes et exports*, postes désignés par l'établissement, document 10) : *Garder l'outil disponible hors réseau sur ce poste* (outil servi en HTTPS) et *Créer une*

copie locale des données sur ce poste (nom du poste, dossier vide sur son disque). En cas de panne du réseau : écran d'accueil → *Travailler hors réseau (copie locale de ce poste)*, bandeau rouge ; au retour : *Verrouiller*, *Changer de dossier*, *Reprendre* le dossier habituel, les saisies sont reprises. Le tableau des dossiers de secours liste chaque copie (serveur, robocopy, copies locales) avec sa dernière mise à jour ; *Retirer de la liste* pour un poste réformé. Sur un poste désigné, un bandeau orange en haut de l'écran signale une copie locale en retard de plus d'une heure, en échec ou dont l'accès a été perdu : *Mettre à jour maintenant* ou *Autoriser l'accès et mettre à jour*.

Fenêtre séparée : le bouton *Installer comme application* (en haut de l'écran, ou sur l'écran d'accueil et de connexion) installe l'outil sur le poste ; il s'ouvre ensuite dans sa propre fenêtre, avec son icône sur le bureau et dans le menu Démarrer, au lieu d'un onglet du navigateur. Le bouton n'apparaît que si le navigateur le permet (Edge ou Chrome, outil servi en HTTPS) et que l'outil n'est pas déjà installé ; le service informatique peut aussi l'installer sur tous les postes (document 03).

Ouverture de l'outil : un poste qui a déjà ouvert le dossier réseau du service, et dont le navigateur a gardé l'accès (réponse « Autoriser à chaque visite »), affiche directement l'écran de connexion. Sinon, ou si le partage est inaccessible (message affiché), l'écran d'accueil propose *Reprendre*.

Réglages : export et import (*Administration → Sauvegardes et exports*) : *Télécharger* ou *Enregistrer dans le dossier des exports* produit un fichier `.json` du paramétrage, rubrique par rubrique (aucune donnée de patient, aucun compte, aucun mot de passe ; numérotation du registre antérieur, rapports annuels et dossier de secours jamais exportés). *Examiner le fichier…* lit un fichier de réglages et affiche les rubriques qui changent : cochez celles à reprendre, puis *Importer*. Les règles légales sont décochées par prudence ; les services et rôles utilisés dans les données ne sont jamais retirés ; les alertes importées ne s'appliquent qu'aux mesures saisies après l'import. L'import apparaît au journal en une ligne (« Import des réglages … »), annulable en une fois.

Choix du dossier bloqué sur les postes (*Administration → Comptes et sécurité*, désactivé par défaut) : une fois activé, chaque poste retient à la connexion suivante les données qu'il utilise. Le mode démonstration n'est plus proposé. L'écran d'accueil ne propose plus alors que *Reprendre* le dossier habituel, *Travailler hors réseau* (copie locale) et *Ouvrir un autre dossier de ces mêmes données* (dossier de secours, nouveau dossier après un déplacement : accepté seulement s'il contient les mêmes données). Pour ouvrir d'autres données ou le mode démonstration, un administrateur clique sur *Débloquer le choix du dossier (administrateur)* et saisit son identifiant et son mot de passe, ou le code de secours ; le blocage reprend à la connexion suivante tant que l'option est active.

Listes et affichage de l'établissement (*Administration → Établissement et services*) : - **Modes d'hospitalisation** : code, libellé, soins sans consentement ou non (soins libres) ; ajout possible (soins sur décision de justice, personne détenue, ordonnance de placement provisoire d'un mineur…). Un code déjà employé n'est ni modifiable ni supprimable. - **Listes de saisie** : fonctions des professionnels chargés de la surveillance, motifs de pause, motifs de fin propres (ajoutés à ceux de l'outil, « Autre » toujours en dernier), raccourcis de durée des pauses (ex. « 30 min ; 1 h ; 1 h 30 »). - **Points de vigilance** : seuils du « cumul élevé » sur 15 jours (rouge : 48 h d'isolement ou 24 h de contention ; orange : 24 h ou 12 h par défaut), sans effet sur les échéances JLD ; durée pendant laquelle une mesure terminée reste dans la liste (15 jours par défaut). - **Écran de connexion et logo** : contact en cas de difficulté (repris sur les fiches de remise des identifiants), consigne de l'établissement, logo affiché dans l'en-tête. Le contenu étant chiffré, l'écran de connexion d'un poste montre ce qui y a été lu à la dernière connexion.

L'onglet *Administration* est organisé en **sous-onglets** : *Comptes et sécurité* (comptes, rôles et accès, clés de sécurité, code de secours, choix du dossier bloqué sur les postes, mode formation), *Établissement et services* (services, chambres de soins intensifs, **appellation des lieux dédiés à l'isolement** — « chambre de soins intensifs (CSI) » par défaut, ou chambre d'isolement (CI), espace

d'isolement, ou une appellation propre, avec aperçu ; seuls les textes de l'outil changent, pas les noms des lieux saisis ni les calculs —, postes de surveillance, **organisation des envois au JLD** : texte libre affiché en tête de l'onglet *JLD*, vide par défaut), *Règles et pauses*, *Alertes*, *Cas particuliers*, *Registre et statistiques* (compteurs, numérotation des mesures importées, colonnes de l'onglet Patients), *Décompte JLD* (masques), *Reprise des données*, *Sauvegardes et exports* (sauvegardes, contrôle d'intégrité, dossier de secours, travail hors réseau, dossier des exports, archive annuelle, réglages) et *À propos* (licence, signalements, informations techniques : version, dossier, nombre de saisies, révision du coffre ; vérification de la version). Le dernier sous-onglet consulté est retenu.

Correction d'une erreur de saisie en l'absence du cadre : l'IDE ou l'AS ouvre le détail de la mesure, bouton *Proposer une correction…* (début, fin, lieu, avec un motif). La correction n'est pas appliquée tout de suite : la mesure garde ses valeurs, un signalement « Correction proposée » s'affiche sur sa ligne et dans les points de vigilance. Le cadre l'examine (ancienne → nouvelle valeur, auteur, motif), puis la valide ou la refuse avec un motif. Tout est tracé au journal.

Patient détenu : case à cocher à la création du patient et dans sa fiche ; badge « détenu » dans l'onglet Patients. L'établissement peut y associer une alerte (*Administration → Alertes*, déclencheur « Patient détenu »).

Changement d'heure : les durées et les échéances sont calculées en heures réelles. Une mesure qui traverse le passage à l'heure d'hiver dure une heure de plus que ne le laisse penser l'horloge (une tranche de 24 h du décompte se termine alors à 19 h pour une mesure débutée à 20 h) ; une heure de moins au passage à l'heure d'été.

Motif du recours et entretien après la mesure (si l'établissement les a activés) : la nouvelle mesure propose un motif du recours (liste de l'établissement, facultatif). Après la fin d'une mesure, le bouton portant le nom choisi par l'établissement (par exemple *Débriefing post-isolement…*) dans le détail permet de noter s'il a été réalisé et quand ; le contenu reste dans le dossier du patient. Les mesures terminées depuis moins de 7 jours sans entretien renseigné apparaissent dans les points de vigilance.

Motif de fin : la fin d'une mesure précise son motif (décision médicale, suite à la mainlevée du JLD — proposé si le juge a levé la mesure —, sortie, transfert hors de l'établissement, passage en soins somatiques ou aux urgences, fugue, décès, motifs propres à l'établissement, autre), avec une précision facultative ; pour « Autre », le motif est à préciser obligatoirement. Pour un décès, un rappel s'affiche : un décès inattendu au regard de l'état de santé est un événement indésirable grave associé à des soins, à déclarer sans délai à l'ARS selon la procédure de l'établissement.

Recours et appel : en dehors des cycles de contrôle, le JLD peut être saisi à tout moment par le patient, ses proches, son avocat… Dans le détail de la mesure, bouton *Recours ou appel…* : saisine du JLD (à l'initiative de…), décision du JLD sur ce recours, appel devant le premier président de la cour d'appel, décision du premier président. Une mainlevée sur recours ou en appel a les mêmes effets qu'une mainlevée du cycle (remise à zéro du cumul après la fin, règle des 48 h). Les recours figurent dans le décompte JLD avec les envois.

Qualité et conservation (*Administration → Registre et statistiques*) : activer le motif du recours (et sa liste), l'entretien après la mesure (et son nom), les traces de surveillance des mesures hors CSI (onglet Surveillance CSI et registre pour les catégories B, D, E), la durée de conservation (l'outil signale les patients dont la dernière mesure la dépasse ; il ne supprime rien). L'**archive annuelle** (registres et statistiques d'une année en CSV, enregistrée dans le dossier des exports et tracée au journal) se trouve dans *Administration → Sauvegardes et exports*.

Méthode des statistiques (*Administration → Registre et statistiques*) : le registre découpe finement les mesures (une contention pendant un isolement donne plusieurs entrées : A, C, A), ce qui peut augmenter le nombre de mesures par rapport aux pratiques antérieures. Les statistiques présentent

donc trois unités de compte : les **entrées du registre**, les **mesures au sens du juge** (isolement et contention séparés) et les **séquences** (entrées d'un même patient qui se suivent, regroupées selon une tolérance réglable de « continu » à 48 h ; durée = somme des entrées). Réglages : tolérance des séquences, unité principale du rapport annuel (entrées du registre par défaut), colonne « Séquences » de l'onglet Patients, méthode de comptage utilisée avant l'outil (texte par année), et mentions affichées sous les statistiques, dans le rapport et l'export : règles de calcul en vigueur, changements de règles datés (relus au journal : pauses, soins somatiques, délai de bascule du mode, numérotation importée, tolérance des séquences), comparaison chiffrée avec la règle antérieure au dernier changement, méthode antérieure. Toutes les années sont recalculées avec les règles actuelles (sauf la règle des soins somatiques, enregistrée à chaque départ) : elles restent comparables entre elles, pas forcément avec des chiffres publiés avant un changement.

Rapport annuel (onglet *Statistiques*, bouton *Rapport annuel (trame)…*) : trame du rapport prévu par l'article L. 3222-5-1 (III), soumis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance. Les chiffres N / N-1 sont repris de l'outil (mesures, patients, durées, CSI, mineurs, soins libres, mainlevées, délais JLD, catégories, motifs du recours, entretiens) ; la politique de l'établissement, son évaluation, les actions prévues et les avis se rédigent dans la fenêtre (enregistrés par l'administrateur), puis *Imprimer / PDF*.

Onglet *Patients* : cumuls 48 h / 15 jours, vigilance, mode d'hospitalisation et statistiques de l'année choisie, dont une colonne **Total** (nombre d'entrées du registre et durée totale de l'année, sans double compte). Le menu **Durées en** affiche les durées en jours et heures, en heures, ou les deux (« 2 j 8 h (56 h) ») ; ce choix est mémorisé sur le poste. Le bouton *Mesures* ouvre la fiche du patient avec, pour l'année (flèches pour changer d'année) : durée totale, isolement seul et contention, **histogramme des heures par mois** (isolement seul et contention empilés ; les heures d'une mesure à cheval sur plusieurs mois ou deux années sont réparties sur les mois réellement couverts, alors que les totaux comptent, comme les statistiques, les entrées débutées dans l'année) et **frise de l'année** où chaque entrée du registre apparaît à sa date (survoler pour le détail).

Droit d'accès d'un patient (onglet *Patients* → *Mesures* → *Exporter ses données (droit d'accès)*, cadre ou administrateur) : fichier CSV réunissant la fiche, les modes d'hospitalisation, les mesures (lieux, pauses, JLD, recours, tiers, motifs, entretien) et les entrées du registre ; les noms des professionnels n'y figurent pas. L'export est tracé au journal.

État des données et sauvegardes (*Administration → Sauvegardes et exports*) : versions du coffre conservées, copie sous scellé, dernière copie de sauvegarde complète, résultat du contrôle d'intégrité. Boutons *Télécharger la copie sous scellé* (à ranger au coffre avec le code de secours, à refaire après chaque nouveau code), *Télécharger une copie de sauvegarde complète* (sur un autre support que le partage ; rappel réglable au tableau de bord, tous les 7 jours par défaut) et *Vérifier maintenant*. Ces fichiers restent chiffrés. Restauration : voir les procédures de secours.

En cas d'anomalie d'intégrité, la même rubrique affiche le **détail** (nature, chemin du fichier, agent, date de la saisie) et propose, selon le cas : *Copier la liste pour le service informatique* (chemins, dates et identifiants de connexion seulement, aucune donnée de patient) ; *Réparer depuis une copie de sauvegarde* (administrateur : seuls les fichiers absents ou illisibles sont remis, après vérification qu'ils s'ouvrent avec la clé de l'établissement ; les fichiers présents ne sont jamais modifiés) ; *Mettre en quarantaine* les fichiers illisibles (déplacés dans le dossier `quarantaine`, jamais supprimés) ; *Prendre acte*, quand la récupération est impossible, avec un motif obligatoire : l'alerte est close pour ces fichiers, la décision figure au journal (*Intégrité des données*) et dans la liste des décisions, et toute nouvelle anomalie déclenche une nouvelle alerte. Ces actions sont tracées au journal. Marche à suivre complète : fiche « Alerte d'intégrité » des procédures de secours.

À propos (bouton *À propos* en haut de l'écran, pour tous les agents ; aussi *Administration → À propos*) : version, licence EUPL 1.2, crédits, lien vers la page du projet sur GitHub et boutons *Signaler un problème* / *Demander une amélioration* (formulaires publics : jamais de donnée réelle ; accès à Internet nécessaire, souvent depuis un autre poste que ceux du réseau de l'hôpital).

Comptes temporaires (*Administration → Comptes et sécurité*) : pour un intérimaire, un vacataire ou un stagiaire, indiquez le dernier jour d'accès à la création du compte (ou en lot, pour toute la liste), ou plus tard avec *Modifier*. La date figure sur la fiche de remise. La connexion est refusée après ce jour ; un badge signale les comptes qui expirent dans les 7 jours et ceux qui ont expiré, et un bouton *Désactiver les comptes expirés* retire leur mot de passe du coffre. Pour prolonger un accès, modifiez la date.

Cas particuliers (*Administration → Cas particuliers*) : - *Nouvelle mesure après une mainlevée du JLD* : l'article L. 3222-5-1 interdit toute nouvelle mesure pendant 48 h après une mainlevée, sauf éléments nouveaux (décrits par le psychiatre dans son certificat), et impose d'en informer le juge sans délai. À la saisie, une alerte rouge rappelle la date de la mainlevée et la fin du délai ; l'échéance « Info avant » de la nouvelle mesure est ramenée à son début (réglable) et un point de vigilance reste au tableau de bord tant que l'information n'est pas saisie. L'alerte concerne toute nouvelle mesure (par défaut) ou seulement celles du même type. - *Mesure débutée avant l'arrivée dans le service* (urgences, autre établissement) : dans la nouvelle mesure, cochez « La mesure a débuté avant l'arrivée dans le service », puis indiquez la date et l'heure de la décision initiale et le lieu d'origine ; le champ de début devient l'heure d'arrivée. Les délais JLD et les cumuls partent de la décision initiale ; le registre et les statistiques du service, de l'arrivée. Le décompte JLD présente la partie antérieure sur une ligne distincte (« avant l'arrivée dans le service »). Saisissez ensuite les étapes JLD déjà faites avec le bouton *JLD*, à leur date. - *Passage en soins somatiques ou aux urgences* : le registre n'est pas demandé dans les services de soins somatiques, la règle est donc choisie par l'établissement : la mesure continue et reste comptée au registre du service avec le lieu indiqué (isolement en B, contention en D) — réglage par défaut ; la mesure continue et cette période est comptée dans un registre dédié (un service créé à cet effet, par exemple « Hébergement somatique » ou « Urgences ») ; la mesure est suspendue jusqu'au retour (période comptée ni dans les délais JLD, reportés d'autant, ni au registre ; ligne « SUSPENDUE » dans le décompte) ; ou la mesure prend fin au départ. Dans le détail de la mesure, bouton *Soins somatiques ou urgences…* (les mesures en cours du patient sont traitées ensemble), puis bouton *Retour* sur la ligne de la mesure. Le choix en vigueur au départ est enregistré avec la saisie. - *Transfert vers un autre service* : bouton *Transfert vers un autre service…* dans le détail de la mesure. La mesure reste unique pour le JLD (mêmes délais, même cycle, même tiers) et elle est répartie au registre : le premier service clôt son entrée à l'heure du transfert, le service d'accueil ouvre la sienne. La fiche du patient est rattachée au service d'accueil. Le détail de la mesure montre les lieux successifs. - *Fiches en double* : à la création d'un patient, une alerte signale les fiches proches (même IPP, même nom et prénom, ou même date de naissance et même nom ou prénom). L'onglet *Patients* liste les fiches peut-être en double ; le cadre de santé les fusionne (bouton *Fusionner*) après avoir vu l'effet sur les cumuls et les échéances JLD, les informations qui diffèrent et les mesures qui se chevauchent. Motif obligatoire ; la fusion est tracée au journal et s'annule depuis le journal.

Alertes de l'établissement (*Administration → Alertes*) : chaque alerte se déclenche pour une situation (patient en soins libres au début de la mesure, patient mineur, protection juridique, contention ou isolement hors CSI, toute contention, toute nouvelle mesure), dans tous les services ou seulement ceux cochés. Elle est soit un **rappel** affiché dans le formulaire de la nouvelle mesure, soit une **personne à informer** dans un délai (sans délai, 15 min… 24 h, compté depuis le début de la mesure). Dans ce cas, à l'enregistrement de la mesure, l'outil demande qui a été informé, comment et quand ; la saisie est tracée au journal et visible dans le détail de la mesure. Tant qu'elle n'est pas faite,

l'information reste dans les points de vigilance du tableau de bord (en rouge, bouton *Tracer l'information*) et un bouton *Informer* apparaît sur la ligne de la mesure. Deux alertes sont proposées : *Patient en soins libres* (informer le cadre de santé ou l'administrateur de garde sans délai ; désactivée par défaut, à activer et adapter) et *Contention hors CSI : exceptions prévues* (rappel du texte de loi et de la seule exception prévue par la Haute Autorité de santé (HAS) ; active). Le message proposé peut être remplacé par celui de l'établissement. Une alerte ne concerne que les mesures saisies après son activation, jamais l'historique importé.

Masques du décompte JLD (*Administration → Décompte JLD*) : choisissez *Masque de l'établissement* ou un service, puis réglez les titres, leur **mise en forme** (taille en points, gras, italique, position à gauche, centrée ou à droite, espace au-dessus en mm, pour la ligne de l'établissement et du service — le service peut être placé à la ligne, sous l'établissement, avec alors sa propre mise en forme — et pour le titre de la mesure ; le sous-titre suit le titre), l'en-tête, le destinataire, le bandeau confidentiel, les données d'identité, les colonnes (cochées et ordonnées avec ↑ ↓) le format des durées et du cumul (en heures, en jours et heures, ou les deux : « 68 h 05, soit 2 j 20 h 05 ») et la durée maximale d'une ligne pour l'isolement (24 h par défaut) et la contention (12 h), 0 pour présenter chaque mesure sur une seule ligne, la mise en évidence (mesure actuelle en surbrillance, mesures antérieures grisées, ou les deux), les sections (dont la date d'édition et l'auteur, séparément), le pied de page, le bloc signature et le **papier à en-tête** : image A4 du papier de l'établissement (celui des courriers, exporté en PNG ou JPEG), sur toutes les pages ou la première seulement, avec les marges du texte en millimètres. Pour imprimer, gardez le format A4 et les marges « par défaut ». L'aperçu se met à jour sur un patient fictif. Un service sans masque propre utilise celui de l'établissement ; *Revenir au masque de l'établissement* supprime le masque propre.

Réglage des **pauses** (*Administration → Règles et pauses*) : - **Activer la levée temporaire** : si l'établissement ne déduit pas les pauses, il peut désactiver la fonction ; le bouton *Pause* disparaît de la page des mesures (les pauses déjà saisies restent dans l'historique, une pause en cours peut être reprise). - **Déduire la durée des pauses du cumul**, puis choisir **où** : pour les délais JLD seulement (échéances, cumuls, décompte ; le registre et les statistiques gardent la durée réelle), ou **partout** (registre et statistiques en durées hors pauses). Dans ce dernier cas, choisir comment le registre traite une pause de la contention seule (le patient reste à l'isolement) : en isolement seul (entrée A supplémentaire, durée de l'isolement exacte) ou laissée dans l'entrée de contention C, sans déduction. - **Interdire la pause de l'isolement seul pendant une contention** (désactivé par défaut) : la contention doit alors être mise en pause elle aussi, ou terminée dans la même saisie. - **Colonne « Levées temporaires » dans le registre** (nombre et durée), en option ; une note sous le registre indique toujours quelle durée est affichée. - Reprise automatique à l'heure prévue, seuils d'alerte et de refus.

Déduire les pauses reporte les échéances JLD de toutes les mesures concernées, y compris passées : décision à prendre avec la direction.

Comptes (rôles, services affectés, accès au mode formation), régénération du jeu de formation, clés de sécurité, code de secours, paramétrage, reprise de l'historique à partir du registre : voir le guide d'installation et les procédures de secours.

En cas de problème

- *Dossier inaccessible* ou application indisponible : appliquez la procédure dégradée papier, puis ressaisissez avec les heures réelles.
- *Mot de passe oublié* : demandez une réinitialisation à l'administrateur ; il vous remettra un mot de passe provisoire, à remplacer dès la connexion.

- *Erreur de saisie* : prévenez votre cadre, qui corrige avec un motif tracé.